感染 ★★★（0~3题）

有芽孢厌氧菌：G+ 杆菌→外毒素（2017）		
	破伤风（2007、2014、2017、2024）	气性坏疽“化粪池”（2011）
病原菌	破伤风梭菌 / 杆菌	梭状芽胞杆菌（多为产气荚膜杆菌、水肿杆菌等混合“气水交加”）
表现	铁钉刺伤等 轻微刺激可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难 / 牙关紧闭）、苦笑面容、角弓反张、膈肌 “咀嚼了才知道是苦的”	肌坏死、明显肿痛 黑色、恶臭、大理石样斑纹、捻发感、皮下气肿 可有溶血性黄疸和血红蛋白尿（α 毒素 / 卵磷脂酶）
预防关键	早期彻底清创切开引流（发病最主要的原因常是第一次清创不彻底）	同左
治疗关键	①防止窒息是关键（重症尽早气管切开） ②破伤风抗毒素 TAT、破伤风免疫球蛋白 TIG（最佳）可中和游离毒素	早期彻底清创切开引流
伤口处理“痒死你”	过氧化氢	过氧化氢或高锰酸钾
抗生素	早期大剂量青霉素（在抗生素中作为首选）、甲硝唑 （氨基糖苷类抗生素无效）	同左

脓肿切开引流小结：抓规律——脓肿尚未形成（没有波动感）暂不切开引流	
	记特殊
破伤风、气性坏疽	早期彻底清创切开引流：预防发作的关键
颌下蜂窝织炎（小儿多见）	早期切开减压：避免窒息
脓性指头炎、化脓性腱鞘炎和滑囊炎、掌深间隙感染	肿痛明显时切开引流 （脓性指头炎避免末节指骨坏死、骨髓炎）
丹毒	不切开引流（非化脓性炎）
寒性 / 冷脓肿 （结核，多无红、热）	尽量不切开引流 仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显（此时不能做病灶清除术）可考虑寒性脓肿切开引流“拿它开刀”